

Phần I : Hãy chọn ý đúng nhất.

•

Điều tra ngang được tiến hành với cách chọn mẫu sau trừ 1 cách:

• Mẫu ngẫu nhiên đơn hoặc hệ thống	• Mẫu tầng hoặc mẫu chùm
• Mẫu ghép cặp	• Mẫu 30 cặp ngẫu nhiên

•

Đặc trưng không thể đề cập đến nghiên cứu trong dịch tễ học mô tả:

• Con người • Không gian	• Thời gian • Căn nguyên
-----------------------------	-----------------------------

•

Trong 1 cộng đồng gồm 1 triệu người, có 1 nghìn người mắc bệnh cấp tính, trong đó có 300 người chết vì bệnh này trong năm. Tỷ lệ chết/mắc vì bệnh này trong năm là:

• 3% • 15%	• 10% • 30%
---------------	----------------

•

Nhận xét nào dưới đây không đúng về nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập:

- Nghiên cứu thuần tập tương lai ít nhạy cảm với các sai lệch
- Nghiên cứu thuần tập tương lai cho phép tính toán trực tiếp tỷ suất mới mắc
- Nghiên cứu thuần tập tương lai có ưu điểm là đã sẵn có số liệu cho việc phân tích nhóm

- Nghiên cứu thuần tập tương lai thường được áp dụng để làm sáng tỏ các yếu tố liên quan đến bệnh hiếm gặp

-

Mẫu số để đo lường tỷ suất mật độ mới mắc của 1 bệnh xảy ra là:

- Số những trường hợp quan sát được
- Số những người bệnh không có triệu chứng
- Số năm quan sát được
- Số người mắc trong theo dõi

-

Một nghiên cứu thuần tập trong 12 năm nhằm đánh giá nguy cơ của hút thuốc lá với bệnh tim mạch người ta thấy tỷ lệ xảy ra cơn đau thắt ngực ở những người hút thuốc lá cao gấp 1,6 lần những người không hút thuốc lá. Chỉ số dùng để đo lường tỷ lệ mắc bệnh xảy ra là:

- Tỷ suất hiện mắc
- Tỷ suất mắc bệnh được chuẩn hóa
- Tỷ lệ chết xác định theo tuổi
- Tỷ suất mới mắc

-

Ở một nghiên cứu cơ bản, điều tra 131 người trong số 1000 người lứa tuổi 60 – 64 đã mắc bệnh mạch vành tim. Chỉ số dùng để đo

lường bệnh

xảy ra là:

- Tỷ suất hiện mắc
- Tỷ lệ mắc bệnh được chuẩn hóa
- Tỷ suất hiện mắc xác định theo tuổi
- Tỷ suất mới mắc

•

Khi một loại thuốc hay một phương pháp điều trị có khả năng làm giảm tỷ lệ chết nhưng không làm khỏi hẳn bệnh sẽ dẫn đến tình huống sau:

- Tỷ suất hiện mắc của bệnh sẽ giảm
- Tỷ suất hiện mắc của bệnh sẽ tăng
- Tỷ suất mới mắc của bệnh sẽ giảm
- Tỷ suất mới mắc của bệnh sẽ tăng

•

Một cộng đồng A có 100 nghìn người. Năm 2000 có 1 nghìn người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao trong đó có 200 nam và 100 nữ. Năm 2001 có 60 người chết trong đó có 50 nam. Tỷ lệ chết do lao là:

- 20%
- 30%
- 6%
- 35%

- Một cộng đồng A có 100 nghìn người. Năm 2000 có 1 nghìn người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao trong đó có 200 nam và 100 nữ. Năm 2001 có 60 người chết trong đó có 50 nam. Tỷ lệ chết riêng phần theo nguyên nhân đối với lao là:

- 60/100 nghìn
- 300/100 nghìn
- 200/1000
- 20%

- Tỷ lệ chết của trẻ em dưới 1 tuổi được đo bằng số trẻ chết:

- Từ 24h đến 1 năm tuổi trên 1000 trẻ sống
- Dưới 6 tháng tuổi trên 1000 trẻ sống
- Dưới 1 năm tuổi trên 1000 trẻ sống

-

Dưới 1 năm tuổi trên 1000 cuộc đẻ

-

Trong 1 cộng đồng bao gồm 100000 người, có 1000 người mắc 1 bệnh, trong đó 200 người chết vì bệnh đó trong 1 năm. Tỷ lệ chết vì bệnh đó là:

-

0,2%

-

2%

-

10%

-

20%

-

Tỷ lệ chết/mắc của
một bệnh là:

-

Tỷ
lệ chết thô/100000 dân

-

Tỷ
lệ chết theo nguyên nhân do bệnh đó

-

Tỷ
lệ phần trăm chết ở các bệnh nhân
• Tỷ lệ chết do bệnh đó trong tất cả
các trường hợp người chết do mọi nguyên nhân

-

Tỷ suất mới mắc bệnh được định nghĩa là:

-

Số

ca hiện có của một bệnh trong 1 thời gian chia cho số dân lúc bắt

đầu thời

gian này

-

Số

ca hiện có của một bệnh trong một thời gian chia cho số dân ở thời điểm giữa

thời gian này

-

Số

ca mới mắc của một bệnh trong 1 thời gian chia cho số dân có nguy cơ lúc bắt

đầu nghiên cứu

-

Số ca mới mắc của một bệnh trong 1 thời gian chia cho số dân ở thời điểm giữa thời gian này

-

Nguy cơ mắc bệnh có thể được đo lường bằng:

-

Tỷ

suất mới mắc

-

Tỷ

suất mới mắc nhân với thời gian trung bình của bệnh

-

Tỷ

suất hiện mắc

-

Tỷ xuất hiện mắc nhân với thời gian trung bình của bệnh

-

Những chỉ số dịch tễ học có lợi ích nhất trong việc xác định các yếu tố nguy cơ, trên cơ sở

đó đề ra những biện pháp can thiệp có hiệu quả là:

-

Tỷ

suất mới mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm

-

Nguy

cơ quy thuộc

-

Tỷ

suất hiện mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm

- Nguy cơ tương đối của bệnh

-

Ví dụ về tỷ suất hiện mắc là:

-

Số

lần bị viêm họng ở trẻ em dưới 3 tuổi hằng năm

-

Tổng

số các trường hợp mới bị ung thư tiền liệt tuyến trên 100000 dân hằng năm

-

Số

bệnh nhân đái đường ở một trường đại học

-

Tổng

số bệnh nhân bị xơ cứng lan tỏa trên 100000 dân hằng năm

-

Vacxin phòng bệnh cúm

được thử nghiệm trên một nhóm người tình nguyện là các nữ y tá trẻ.

Trong số 95

cá nhân được nhận tiêm vaccin, có 3 trường hợp bị ốm và trong số 95 cá nhân đã

nhận placebo, có 16 trường hợp mắc bệnh

cúm trong thời gian theo dõi. Tính toán nguy cơ tương đối (RR) nhiễm

bệnh cúm trong số những người nhận vacxin và so với những người nhận placebo:

- 16/3
- 3/16
- 3/93
- 16/96

•

Trong 1 nghiên cứu theo dõi bệnh sốt rét tại huyện miền núi có sử dụng thuốc artemisinin để điều trị cho bệnh nhân sốt rét. Qua theo dõi

1892 trường hợp thấy x trường hợp mới mắc trong thời gian theo dõi 2 năm (1999 – 2001). Tính tỷ suất mắc tích lũy của sốt rét trong thời gian nghiên cứu.

- 0.13
- 0.15
- 0.19
- 0.17

•

Trong 1 nghiên cứu sàng lọc tiến hành trên 5000 phụ nữ người ta tìm được 25 người mắc ung thư vú. Năm năm sau đó, người ta phát hiện thêm x trường hợp bị bệnh. Tỷ suất mới mắc ung thư vú sau 5 năm nghiên cứu là:

- - 10/(5000-25)
- - 10/5000
- - 10/25
- - 10/(5000+25)
- Nghiên cứu dịch tễ học mô tả dung để nhằm mục đích sau trừ:

 - Đánh giá chiều hướng sức khỏe cộng đồng
 - Cở sở cho việc lập kế hoạch và đánh giá các dịch vụ y tế
 - Xác định vấn đề cần nghiên cứu hình thành giả thuyết
 - Xác định yếu tố nguy cơ
- Nghiên cứu dịch tễ học mô tả nhằm:

 - Xác định mối liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh
 - Kiểm định giả thuyết
 - Chứng minh giả thuyết
 - Hình thành giả thuyết
- Mô tả một trường hợp bệnh hoặc một chùm bệnh có những ưu điểm sau trừ:

- - Đơn giản, nhanh, dễ làm
 -
 - Cơ sở ban đầu cho hình thành giả thuyết
 -
 - Xác định căn nguyên trong thời gian ngắn
 -
 - Cơ sở ban đầu cho việc xác định sự xuất hiện một vấn đề sức khỏe
- - Điều tra ngang không gắn liền với tỉ lệ nào sau đây:
 -
 - Tỉ suất hiện mắc
 -
 - Tỉ suất mới mắc
 -
 - Tỉ suất hiện mắc điểm
 -
 - Tỉ suất hiện mắc kì
- - Nhược điểm cơ bản của các nghiên cứu bệnh chứng về vai trò của yếu tố bệnh can nghi ngờ khi so sánh với nghiên cứu thuần tập tương lai là:
 -
 - Tồn kém hơn và kéo dài hơn
 -
 - Có thể có sai số hệ thống trong việc xác định sự có mặt hay không có mặt của yếu tố nguy cơ
 -
 - Có thể có sai số hệ thống trong việc xác định sự có mặt hay không có mặt của hậu quả bệnh

- - Khó chọn nhóm đối chứng
- - Kỹ thuật ghép cặp được áp dụng trong nghiên cứu bệnh chứng để:
 - Kiểm soát các biến số đã được biết là có ảnh hưởng đến sự phân bố của bệnh mà ra nghiên cứu ở cả hai nhóm bệnh và nhóm chứng
 - Có thể nghiên cứu được ảnh hưởng của các biến số được ghép
 - Kết quả được quy cho ảnh hưởng của các biến số được ghép
 - Giảm được mẫu nghiên cứu
- - Một nghiên cứu bệnh chứng có các đặc điểm sau, trừ:
 - Không quá tốn kém
 - Có thể ước lượng được nguy cơ tương đối
 - Có thể ước lượng được tỉ suất mới mắc
 - Có thể chọn nhóm đối chứng từ những chứng bệnh khác
- - Nhóm chứng trong nghiên cứu thuần tập là nhóm
 - Giống nhóm chủ cứu về tất cả các đặc điểm trừ phơi nhiễm nghiên cứu
 - Nhóm bệnh nhân đủ các tiêu chuẩn nghiên cứu

- - Nhón người khỏe mạnh không mắc bệnh nghiên cứu
 - Nhóm người tiếp xúc với yếu tố phơi nhiễm đang nghiên cứu
- Thông tin về phơi nhiễm ít gặp sai số nhất trừ những nguồn nào sau đây:
 - Hồ sơ có từ trước
 - Hồi đối tượng nghiên cứu
 - Khám sức khỏe hay là xét nghiệm trực tiếp
 - Điều tra môi trường nước và không khí trực tiếp
- Trong nghiên cứu thuần tập thường không tính:
 - Tỷ suất mới mắc
 - Tỷ suất chênh (QR)
 - Nguy cơ tương đối (RR)
 - Nguy cơ quy thuộc
- Sai số hay gặp nhất trong nghiên cứu thuần tập là
 - Sai số lựa chọn
 - Sai lệch phân loại

- - Ảnh hưởng của việc mất các đối tượng nghiên cứu trong quá trình theo dõi
- - Ảnh hưởng của sự không tham gia nghiên cứu
- - Ưu điểm của nghiên cứu thuần tập là:
 - Ước lượng chính xác hơn về nguy cơ mắc bệnh
 - Rất tốn kém về kinh phí và thời gian nếu là thuần tập lồng ghép bệnh chứng
 - Cần phải có hồ sơ đầy đủ nếu là nghiên cứu thuần tập hồi cứu
 - - Giá trị của kết quả nghiên cứu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất đối tượng nghiên cứu trong quá trình theo dõi
- - Trong một nghiên cứu nhằm xác định liệu việc cắt bỏ amidan có kết hợp với sự phát triển sau này của bệnh Hodgkin, nguy cơ tương đối ước lượng sự phát triển bệnh Hodgkin ở những người đã cắt amidan là 2,9 với $p < 0,03$. Từ kết quả này có thể kết luận là:
 - Tỷ lệ chết/mắc ở những người đã cắt amidan cao hơn
 - Nguyên nhân gây Hodgkin là do cắt amidan
 - Cắt amidan có thể bảo vệ chống lại sự phát triển Hodgkin
 - Tỷ suất mới mắc của bệnh Hodgkin ở những người cắt amidan trước đây cao gấp 2,9 lần so với những người không cắt amidan

- Bảng sau trình bày nguy cơ tương đối được tính bằng tỉ suất của các tỉ lệ tử vong liên quan với hai phương pháp điều trị ở bệnh viện A và bệnh viện B

Phương pháp	Nguy cơ tương đối (A/B)	P
Mổ đẻ	0,5	0,05
Nối động mạch vành	2,0	0,10

Nhận xét

nào sau đây có giá trị cho nhưng số liệu này

- Nguy cơ tử vong liên quan phẫu thuật nối động mạch vành ở bệnh viện A gấp 2 lần so với bệnh viện B
 - Nguy cơ tử vong do mổ đẻ giữa 2 bệnh viện có khác nhau chút ít nhưng khác biệt nhỏ này lại có ý nghĩa thống kê
 - Nguy cơ tử vong do mổ đẻ ở bệnh viện B lớn gấp 2 lần so với bệnh viện A khác biệt có ý nghĩa thống kê
 - Giá trị P gợi ý rằng nguy cơ chết vì mổ đẻ là quan trọng gấp 2 lần so với nguy cơ chết vì bệnh mạch vành tim
- Năm 19985 có 1000 phụ nữ làm việc ở phân xưởng sản xuất của nhà máy hóa chất. Tỉ suất mới mắc ung thư xương của những phụ nữ này vào năm 2005 đã được so sánh với 1000 phụ nữ làm việc ở khu vực văn phòng vào năm 1985, 20 phụ nữ ở phân xưởng sản xuất và 4 phụ nữ ở khu vực văn phòng đã bị

ung thư

xương trong khoảng thời gian từ 1985-2005. Nguy cơ tương đối phát triển

ung thư

xương ở những người ở phân xưởng sản xuất là:

- 2
- 4
- 5
- 8

•

Thử nghiệm nào dưới đây không phải Nghiên cứu can thiệp lâm sàng:

- Thử nghiệm thuốc điều trị trên lâm sàng
- Thử nghiệm phương pháp điều trị nội khoa, ngoại khoa, vật lý trị liệu...
- Thử nghiệm phương pháp điều trị nói chung
- Thử nghiệm vaccine phòng bệnh

•

Giai đoạn IV trong thử nghiệm thuốc điều trị không bao gồm:

- Giám sát các ảnh hưởng phụ của thuốc
- Các nghiên cứu bổ sung lâu dài trên phạm vi lớn về tỉ lệ mắc bệnh

- - Các nghiên cứu bổ sung lâu dài trên phạm vi lớn về tỉ lệ tử vong
 - Đánh giá chi phí hiệu quả của thuốc
- Trong nghiên cứu can thiệp không cần cân nhắc điểm nào dưới đây:
 - Đạo đức
 - Khả năng thực hiện
 - Giá thành
 - Thời gian tham gia vào nghiên cứu của nhóm đối chứng
- Tăng cường sự tuân thủ trong nghiên cứu can thiệp bằng cách
 - Lựa chọn quần thể nghiên cứu phải đáng tin cậy và quan tâm đến nghiên cứu
 - Người nghiên cứu phải giám sát sự tuân thủ
 - Người nghiên cứu phải thông báo thường xuyên tỉ lệ người tuân thủ
 - Người nghiên cứu làm xét nghiệm thường xuyên cho nhóm can thiệp
- Không chế sai số trong nghiên cứu can thiệp bằng

- - Cỡ mẫu nghiên cứu đủ lớn
 - Phân bố ngẫu nhiên
 - Kỹ thuật làm mù
 - Kỹ thuật chạy thử
- - Mù kép là kỹ thuật
 - Chỉ có điều tra viên biết kỹ thuật nghiên cứu
 - Chỉ có đối tượng nghiên cứu biết kỹ thuật nghiên cứu
 - Cả điều tra viên và đối tượng nghiên cứu đều không biết kỹ thuật nghiên cứu
 - Cả điều tra viên và đối tượng nghiên cứu đều biết kỹ thuật nghiên cứu
- - Nghiên cứu “ làm mù kép” một loại vaccine là một nghiên cứu trong đó:
 - Nhóm nghiên cứu nhận vaccine và nhóm chứng nhận placebo
 - Cả người nghiên cứu lẫn đối tượng nghiên cứu đều không biết bản chất của placebo
 - Cả người nghiên cứu lẫn đối tượng nghiên cứu không ai biết sẽ nhận vaccine, ai sẽ nhận placebo

- - Những người ở nhóm chứng không biết những người ở nhóm nghiên cứu
- - Trong một nghiên cứu đo lường tần số các triệu chứng phụ do dùng một thuốc điều trị
 - - Nhóm đối chứng không dùng thuốc là cần thiết để giải thích kết quả
 - - Nhóm đối chứng nhận placebo là cần thiết để giải thích kết quả
 - - Sự đa thêm nhóm chứng vào có thể làm cho người nghiên cứu nhầm lẫn, đặc biệt là nếu tỉ lệ phản ứng phụ thấp
 - - Sự mong muốn có nhóm chứng phụ thuộc vào loại phản ứng phụ sẽ xảy ra
- - Nhận xét nào sau đây mô tả ưu điểm chủ yếu của thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên
 - - Nó tránh được sai lệch quan sát
 - - Nó thích ứng về đạo đức
 - - Nó mang lại kết quả có thể áp dụng được ở những bệnh nhân khác
 - - Nó loại trừ được sự tự chọn của đối tượng nghiên cứu vào nhóm điều trị khác nhau

- - Hạn chế kết hợp giả tạo bằng
 - Chọn ngẫu nhiên
 - Giới hạn cỡ mẫu nghiên cứu
 - Không chế sai số nhớ lại
 - Không chế sai số bỏ cuộc
- Bảng sau trình bày kết quả của một nghiên cứu về các yếu tố có liên quan đến đáp ứng đối với chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung

Tầng lớp xã hội		Tỉ lệ % đáp ứng		
Cao		75		
Thấp		46		
Cả cao và thấp		53		
Tình trạng hôn nhân				
Có gia đình		82		
Sống độc thân		68		
Góa hay li dị		43		
Tất cả các tình trạng hôn nhân		53		
Tầng lớp xã hội	Có gia đình	Độc thân	Góa/li dị	Chung
Cao	83	67	43	75
Thấp	81	69	43	46
Chung	82	68	43	53

Từ các số liệu trên, suy luận nào sau đây là đúng:

- Phụ nữ có gia đình đáp ứng tốt
- Không thể rút ra kết luận gì từ những số liệu này vì không biết được tình trạng hôn nhân của những người ở tầng lớp xã hội cao vào thấp
- Những phụ nữ có gia đình có tỉ lệ đáp ứng cao hơn những người sống độc thân góa bụa bởi vì nhiều người trong số họ không thuộc tầng lớp xã hội cao
- Không thể rút ra kết luận gì từ các bảng số liệu này vì không biết được đây là nghiên cứu thuần tập hay nghiên cứu bệnh chứng

•

Chọn tình huống đúng

Người ta nghiên cứu kĩ lưỡng sự kết

hợp giữa hút thuốc lá và ung thư phổi

Những kết luận nào sau đây khẳng

định sự kết hợp giữa hút thuốc lá và ung thư phổi và đưa được ra bằng chứng về

mối quan hệ nhân quả?

- Nguy cơ ung thư phổi tăng lên khi số thuốc lá hút hàng ngày tăng lên
- Nguy cơ ung thư phổi tăng lên khi khoảng thời gian hút thuốc lá dài hơn

- Những người bỏ thuốc là có tỉ lệ ung thư phổi ở mức trung gian so với những người không hút thuốc lá và những người hiện đang hút thuốc lá
- Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy tỉ lệ có vết loét tiền ung thư tăng lên sau khi hít khói thuốc lá vào phổi

So sánh tỉ lệ tử vong do ung thư tử cung ở những người có và không dùng nội tiết tố Oestrogen cho thấy rằng:

	Tỉ lệ tử vong/100.000	
	Tuổi 40-50	Tuổi 55-70
Dùng Oestrogen	3,0	17,0
Không dùng Oestrogen	1,0	6,0

Kết luận có giá trị thu được từ số

liệu trên có liên quan tới tỉ lệ tử vong ở những người dùng Oestrogen là:

- Có thể có mối quan hệ nhân quả giữa sử dụng Oestrogen và tỉ suất mới mắc của ung thư cổ tử cung
- Có mối quan hệ nhân quả giữa sử dụng Oestrogen và tỉ suất mới mắc của ung thư tử cung
- Mối quan hệ nhân quả giữa sử dụng Oestrogen và tỉ suất mới mắc của ung thư cổ tử cung tăng lên theo tuổi không liên quan với việc sử dụng Oestrogen
- Tỉ lệ tử vong ở những người không dùng Oestrogen thấp hơn so với người dùng Oestrogen vì những triệu chứng ung thư tử cung

đã phát hiện sớm

hơn ở người không dùng Oestrogen

-

Nguyên tắc phiên giải kết quả của trắc nghiệm thống kê

-

Không được áp dụng
máy móc và cứng nhắc giá trị P

-

Ý nghĩa thống kê chưa cân nhắc tới ý nghĩa sinh học hay lâm sàng

-

Giá trị p đã chứa đựng thông tin về sai số hệ thống

-

Giá trị p chưa chứa đựng thông tin về yếu tố nhiễu

-

Nhiều là yếu tố:

-

Nằm ngoài kết hợp phơi nhiễm và bệnh

-

Làm thay đổi mức độ kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh

-

Có liên quan tới cả phơi nhiễm và bệnh

-

Kết hợp giữa nhiễu và bệnh không phải là kết hợp căn nguyên

51. Kỹ thuật ghép cặp dùng để

A. Kiểm soát các biến số đã được biết là có ảnh hưởng đến sự phân bố của bệnh

mà ta nghiên cứu ở cả 2 nhóm bệnh và nhóm chứng

B. Có thể nghiên cứu ảnh hưởng của các biến số được ghép cặp

C. Kết quả không được quy cho ảnh hưởng của các biến số được ghép cặp

D. Dùng trong nghiên cứu bệnh chứng mà không dùng trong nghiên cứu thuần tập

52. Những hạn chế của kỹ thuật ghép cặp là A. Ghép cặp là kỹ thuật khó

B. Không tốn kém về kinh phí và thời gian

C. Rất khó chọn ra được những cặp ghép chặt chẽ theo đúng và đủ tiêu chuẩn về từng biến số nhiều

D. Ghép cặp không có khả năng đánh giá được hậu quả của 1 yếu tố được ghép cặp

53. Động vật là nguồn truyền nhiễm của bệnh

A. Thương hàn

B. Bệnh dại

C. Bệnh tả

D. Bạch hầu

54. Các loài chim là ổ chứa trong thiên nhiên của bệnh

A. Viêm gan B

B. Sốt xuất huyết C. Dịch hạch D. Viêm não Nhật Bản

55. Bệnh lây truyền theo đường phân – miệng là A. Bệnh tả

B. Bệnh sốt phát ban

C. Bệnh sốt rét

D. Bệnh đại

56. Các bệnh truyền nhiễm được phân loại dựa vào

A. Đặc tính vi sinh vật gây bệnh

B. Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh

C. Vị trí cảm nhiễm thứ 2 của vi sinh vật gây bệnh

D. Biểu hiện lâm sàng

57. Dịch được định nghĩa là

A. Một bệnh có tỷ lệ mắc thấp nhưng thường xuyên xảy ra trong 1 cộng đồng hay 1 vùng

B. Bệnh có tỷ lệ tấn công vượt quá 10/1000 dân

C. Sự xuất hiện của bệnh vượt quá số mong đợi trung bình ở quần thể đó trong thời gian đó

D. Tỷ lệ mắc bệnh hàng năm / 100.000 dân

58. Nguồn truyền nhiễm chính của bệnh viêm não Nhật Bản là

A. Dê, cừu

B. Người bệnh

C. Chim, lợn

D. Người khỏi mang virus

59. Đường lây truyền phổ biến nhất của bệnh dịch hạch là A. Đường hô hấp

B. Đường tiêu hóa

C. Đường máu

D. Đường da và niêm mạc

60. Gây miễn dịch chủ động phòng chống bệnh bạch hầu có hiệu quả nhất là sử dụng

A. Độc tố

B. Kháng độc tố

C. Huyết thanh người mới khỏi bệnh

D. Giải độc tố

61. Chẩn đoán phát hiện sớm 1 bệnh nhân trong 1 vụ dịch KHÔNG dựa vào

A. Chẩn đoán lâm sàng

B. Chẩn đoán xét nghiệm

C. Điều tra dịch tễ học

D. Các nghiên cứu dịch tễ học phân tích

62. Các biện pháp chủ yếu để phòng chống các bệnh truyền nhiễm là A. Các biện pháp đối với nguồn truyền nhiễm

B. Các biện pháp đối với đường truyền nhiễm

C. Các biện pháp tăng cường sức đề kháng cho nhân dân

D. Tất cả các biện pháp kể trên

63. Nhìn chung biện pháp phòng chống có hiệu quả đối với các bệnh truyền nhiễm

đường tiêu hóa là

A. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân

B. Các đường truyền nhiễm

C. Phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân

D. Tiêm vaccin phòng bệnh

64. Nhìn chung các biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh truyền

nhiễm đường hô hấp là

A. Phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân

B. Cách ly và khử trùng chất thải của bệnh nhân

C. Cắt đường truyền nhiễm

D. Tiêm vaccin phòng bệnh

65. Mục đích điều tra dịch tễ học tại khu dịch là

A. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp

B. Tính tỉ suất hiện mắc

C. Chọn biện pháp thích hợp nhất để xử lí khu dịch

D. Đánh giá trình độ chuyên môn của cán bộ y tế cơ sở

66. Phương pháp có hiệu quả nhất phòng chống HIV/AIDS là

A. Phát hiện cách ly và điều trị sớm người bị nhiễm HIV

B. Thực hiện tốt kiểm dịch biên giới

C. Thanh toán các tệ nạn xã hội như ma túy.mại dâm

D. Giáo dục thay đổi hành vi và xây dựng hành vi an toàn

67.Vacxin không được để ở nhiệt độ đông băng là

A. Vacxin sabin

B. Vacxin sởi

C. Vacxin BCG

D. Vacxin BH-HG-UV

68. Vacxin tiêm 3 lần lúc 2,3 và 4 tháng tuổi là

A. Vacxin BH-HG-UV

B. Vacxin sởi

C. Vacxin sabin

D. Vacxin BCG

69. Không tiêm Vacxin uốn ván trong trường hợp sau

A. Đang bị bệnh cấp tính

B. Đang mắc lao

C. Có bệnh về máu

D. Tất cả các trường hợp trên

70. Vacxin tiêm cho trẻ lúc 9 đến 12 tháng tuổi là

A. Vacxin BH-HG-UV

B. Vacxin sởi

C. Vacxin sabin

D. Vacxin viêm gan B

71. Những bệnh nào dưới đây tác nhân gây bệnh không phải virus

A. Bệnh sởi

B. Bệnh ho gà

C. Bệnh thủy đậu

D. Bệnh quai bị

72. Cúm là 1 trong những bệnh gây nên đại dịch lớn vì

A. Sự thay đổi kháng nguyên của virus

•
Sự lây truyền qua nướcC. Thời kỳ ủ bệnh lâu dàiD. Không có Vaccin đặc hiệu

73. Điều nào dưới đây phù hợp với bệnh cúmA. Tác nhân gây bệnh là 5 loại virus Influenza A,B,C,D,E

B. Virus cúm B và C hay gây ra các trận dịch lớn cho cộng đồng

C. Người bệnh và người lành mang trùng là nguồn bệnh duy nhất

D. Bệnh cúm bắt đầu lây khi bệnh nhân khởi sự sốt cao

74. Bệnh sởi có những đặc tính sau

A. Có miễn dịch không bền,do đó cần phải tiêm chủng

B. Mức độ lây lan thấp

C. Luôn luôn diễn biến qua các giai đoạn viêm long,phát ban,hồi phục

D. Rất khó chẩn đoán vì khó phân lập được tác nhân gây bệnh

75. Đối với những bệnh truyền nhiễm đường hô hấp có hiện tượng tăng băng,biện

pháp phòng chống quan trọng là

A. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân

B. Phát hiện sớm và điều trị triệt để cho bệnh nhân

C. Tăng cường giáo dục sức khỏe và các biện pháp dự phòng cấp 1

D. Chẩn đoán và cách ly sớm

76. Tiêm chủng ho gà chống chỉ định ở người

A. Trên 3 tuổi

B. Trên 6 tuổi

93. Cách tốt nhất để phòng HIV/AIDS là cấm các hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức và trừng phạt những người nghiện chích ma túy để họ phải bỏ tiêm chích. Nếu chính phủ áp dụng những biện pháp như thế sẽ hạn chế được số người nhiễm HIV/AIDS

A. Điều này không đúng, bởi vì sẵn lung những người hành nghề mại dâm và nghiện chích ma túy chỉ là 1 chính sách về hình thức. Họ sẽ tiếp tục những gì mà họ đang làm và các nhà chức trách không thể kiểm soát họ

B. Điều này không đúng, bởi vì đường lây truyền HIV quan trọng là tình dục đồng giới nam

C. Điều này không đúng bởi vì chính phủ cần phải tiếp xúc với họ và đề nghị cộng tác tham gia vào chương trình phòng chống AIDS

D. Điều này hoàn toàn không đúng

94. Đối với chương trình phòng chống HIV/AIDS một điều rất quan trọng là thanh niên phải thực hiện tình dục an toàn. Tuy nhiên đừng nên nói quá nhiều với họ về điều đó vì nó chỉ khuyến khích thêm họ làm những điều mà họ đáng nhẽ không nên làm. Tốt nhất là nên khuyên họ đừng có quan hệ tình dục cho đến khi lập gia đình

A. Điều này là đúng

B. Điều này là không đúng, bởi vì kết quả nghiên cứu cho thấy rằng thanh niên sau khi được nghe giáo dục về tình dục sẽ không có quan hệ tình dục khi còn trẻ

C. Điều này là không đúng, bởi vì giáo dục về tình dục an toàn với người lớn khi đã có quan hệ tình dục rồi thì hiệu quả hơn. Tốt hơn là nên đợi cho khi đến đó

D. Điều này là đúng, nhưng nên hạn chế ở những trường hợp thấp hơn vì thanh thiếu niên ngày nay có quan hệ tình dục sớm hơn

95. Các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng là

A. Thức ăn giàu mỡ và đạm động vật

B. Thức ăn có nhiều rau

C. Hoa quả

D. Virus viêm gan B

96. Biện pháp có hiệu quả phòng bệnh ung thư gan nguyên phát

A. Tiêm vaccin viêm gan B cho trẻ em

B. Tập thể dục

C. Thức ăn có nhiều rau

D. Chẩn đoán phát hiện sớm

97. Biện pháp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

A. Khám lâm sàng

B. Xét nghiệm tế bào cổ tử cung

C. Siêu âm

D. Xét nghiệm máu

98. Bệnh tim mạch là mô hình bệnh tật của

A.

B.

C.

D.

99. Bệnh tai biến mạch máu não là bệnh có các biểu hiện sau

A. Tổn thương chức năng thần kinh khu trú đột ngột do chấn thương, tồn tại ngắn

B. Tổn thương chức năng thần kinh khu trú đột ngột không do chấn thương dưới 24 giờ

C. Tổn thương chức năng thần kinh khu trú đột ngột không do chấn thương dài hơn 24 giờ, có thể để lại di chứng

D. Tổn thương chức năng thần kinh khu trú đột ngột do chấn thương, kéo dài để lại di chứng

100. Virus gây u nhú là yếu tố nguy cơ gây ung thư

A. Cổ tử cung

B. Dạ dày

C. Phổi

D. Thực quản

Phần II: ĐÚNG – SAI

1. Sàng tuyển phát hiện ung thư vú sớm và điều trị là biện pháp dự phòng cấp 2

2. Phát hiện sớm tăng huyết áp giới hạn, điều trị kịp thời, làm cho huyết áp trở về bình thường là biện pháp dự phòng cấp 1

3. Phụ nữ có thai mắc sốt rét sẽ có khả năng truyền sang thai nhi

4. Miễn dịch trong sốt rét là dạng miễn dịch tự nhiên

5. Miễn dịch trong sốt rét là miễn dịch bền vững suốt đời

6. Một số loài chim hoang dã là khối

cảm thụ của bệnh dịch hạch

7. Người mang mầm bệnh Thương hàn là nguồn lây truyền

bệnh

8. Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa là: Phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân

9. Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh truyền nhiễm đường

tiêu hóa là: Cắt được đường truyền nhiễm

10. Tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa thương tăng cao vào các tháng

ấm, lạnh

11. Trong bệnh cúm, người bệnh và người lành mang trùng là nguồn bệnh duy nhất

12. Các biện pháp phòng chống dịch của nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp thì

đường truyền là rất dễ thực hiện

13. Các bệnh truyền nhiễm đường hô

hấp diễn biến quanh năm và hay gặp vào những tháng lạnh, ẩm

14. Miễn dịch tự nhiên chủ động hình thành sau khi bị nhiễm trùng có triệu

chứng hay không có triệu chứng lâm sàng

15. Miễn dịch nhân tạo chủ động khi đưa các kháng

nguyên vào cơ thể để tạo ra

kháng thể

16. Yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng nhiều đến yếu tố truyền nhiễm

17. Vị trí cảm nhiễm thứ 2 quyết định con đường giải phóng vi sinh vật ra khỏi

vật chủ cũ

18. Nghiên cứu bệnh chứng khó xác định mối quan hệ về mặt thời gian giữa phơi nhiễm và bệnh

19. Nghiên cứu bệnh chứng có hiệu quả khi nghiên cứu các phơi nhiễm

20. Phải thông báo quốc tế các bệnh: dịch tả, sốt vàng, dịch hạch